

绪论 (Introduction) 考点总结

来源: 第一章 绪论.pdf, 共5页

一、核心考点概述

外科学的定义与内涵, 外科疾病分类 (7类), 现代外科学发展里程碑 (解剖、麻醉、输血、无菌术、手术基本技术), 外科诊疗基本原则 (严于术前、精于术中、勤于术后), 外科规范 (生命权、知情同意、隐私权), 以及生物-心理-社会模式是高频考点。

二、重点概念与定义

- **外科 (surgery)**: 希腊词 cheir (手) + ergon (工作), 即用"手"治疗疾病的专科 [P1]
- **外科疾病 (surgical diseases)**: 只有通过手术或手法整复处理才能获得最好治疗效果的疾病 [P1]
- **外科学 (surgical science)**: 研究外科疾病诊断、预防、治疗及发生发展规律的学科 [P1]
- **抗菌术 (antisepsis)**: Semmelweis 用漂白粉溶液洗手降低产褥热, 为抗菌术开端 [P2]
- **无菌术 (asepsis)**: Bergmann 创用蒸汽灭菌法, 由抗菌术演进至无菌术 [P2]
- **生物-心理-社会模式 (biopsychosocial model)**: 外科医生须注意生命整体与部分、躯体与精神、病人社会角色的关系 [P5]

三、关键公式与判据

- 外科诊疗基本原则口诀: **正确诊断, 充分准备; 满意麻醉, 准确定位; 仔细解剖, 减轻损伤; 根除伤病, 力保功能; 加强护理, 促进康复** [P4]
- 三原则: **严于术前** (严格掌握手术指征和时机)、**精于术中** (精湛手术技能)、**勤于术后** (勤观察、勤处理、勤沟通) [P4]
- 麻醉安全性原则 (危亦林): "若其人如酒醉, 即不可加药"—**严格掌握麻醉药用量** [P1]

四、分类/分型/分期

外科疾病七大分类 [P3]

分类	举例	治疗特点
损伤	内脏破裂、骨折、烧伤	修复组织、恢复功能
感染	化脓性阑尾炎、肝脓肿	手术切除感染病灶
肿瘤	良性/恶性肿瘤	切除根治或缓解
畸形	唇腭裂、先天性心脏病	手术整复
内分泌功能失调	甲状腺功能亢进	手术切除病变腺体
寄生虫病	肝棘球蚴病、胆道蛔虫病	手术取出
其他	肠梗阻、结石、大出血	常需手术治疗

易错点：外科疾病并非都需手术，急性胆囊炎早期先抗感染；内科疾病如肝豆状核变性晚期可需肝移植。内外科界限已模糊 [P3]

外科专业分科 [P3]

- 二级学科：临床外科（大外科）；三级学科：骨科、泌尿外科、神经外科、血管外科、普通外科
- 四级学科（亚专科）：甲状腺外科、乳腺外科、肝胆外科、胃肠外科

五、鉴别诊断/对比

对比项	内科	外科
主要疗法	药物	手术/手法
疾病范围	内脏器官疾病（传统）	体表创伤、疮疡（传统）
现代关系	交叉融合，界限模糊	腔镜/内镜使内外科融合 [P3]

六、易错点与技巧

- 易错：认为外科=手术。片面强调手术是有害的，必须先确定诊断和手术适应证 [P4]

- **易错**：十二指肠溃疡的历史演变考频高：胃空肠吻合→胃大部切除→迷走神经干切断→选择性迷走神经切断→高选择性迷走神经切断→PPI药物治疗（现仅并发症需手术） [P4]
- **记忆技巧**：现代外科五大基础—**解麻血感技**（解剖、麻醉、输血、感染控制、手术基本技术） [P2]
- **法律法规考点**：生命权（切除器官须签字同意）、知情同意权（不作为也要担责）、隐私权（病情也属隐私） [P5]
- **无菌术里程碑人物**：Semmelweis(漂白粉洗手)→Lister(苯酚)→Koch(发现病原菌)→Bergmann(蒸汽灭菌)→Halsted(橡皮手套) [P2]
- **缝合技术里程碑**：Lembert（浆膜对浆膜小肠吻合原则）、Carrel（三定点缝线，1912年诺贝尔奖） [P2]

七、考点速记

- 外科一词源于希腊 cheirergon = 手 + 工作 [P1]
- 中医外科最早称"疡科"，主治未溃肿物、已溃疮疡、刀枪箭伤及骨折 [P1]
- 现存最早医方《五十二病方》有疝带疝罩治疗腹股沟疝 [P1]
- 华佗：酒服麻沸散，死骨剔除术、剖腹术 [P1]
- 危亦林：悬吊复位法治脊柱骨折（比西方早600年） [P1]
- 蔺道人：肩/髋关节脱臼手法复位 [P1]
- 申斗垣：外科器械煮沸处理（比西方早200年） [P2]
- Gray 1859年出版《图解和外科的解剖学》沿用至今 [P2]
- Long 1842年乙醚全麻，Simpson 1847年氯仿麻醉 [P2]
- Landsteiner 1901年发现血型 [P2]
- Fleming 1928年发现青霉素，Domagk 1935年百浪多息（磺胺类） [P2]
- Wells 1872年止血钳，Esmarch 1873年止血带，Pringle 1908年肝十二指肠韧带阻断 [P2]
- "两减一保"：加速术后康复理念，20世纪60-70年代提出 [P2]
- 第四次工业革命：AI、MR、手术机器人、远程医疗、3D打印、BCI [P3]
- 外科三大基本功：切开、分离、止血、结扎、缝合 + 引流、换药 [P4]
- 纽伦堡法典核心：人类试验必须是自愿的 [P5]
- 赫尔辛基宣言1964年进一步发展 [P5]